SDD 88 - Sujet n°2

Spécialité : Dermatologie

Date : 01/04/2024
Auteur : Quentin HARDY (ECN 2022, Dermatologie - Brest)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (ECN 2023, Médecine interne - Paris), Clément FILLIOL (ECN 2022, Radiologie - Lyon)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	116 - Prurit
Situation(s) de départ en lien avec la station	88 - Prurit
Matériel nécessaire à la station	2 chaises, un bureau
Contexte de la station	Consultation de médecine générale, en ville

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes médecin généraliste en ville.

Vous recevez Mme B., 81 ans, patiente que vous rencontrez pour la première fois.

Elle se plaint d'un prurit intense depuis 6 mois, généralisé.

Vous avez déjà examiné son corps entier, et vu seulement des lésions de grattage sur le tronc et les membres.

Vous allez l'interroger pour comprendre la cause de son prurit.

Consignes :

Vous devez réaliser en 8 minutes, incluant la lecture de ces consignes :

- Interroger le patient pour identifier la cause la plus probable de son prurit
- Conclure avec votre hypothèse diagnostique principale

Vous ne devez pas :

- Examiner le patient standardisé
- Prescrire d'examen complémentaire
- Débuter de traitement

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche des antécédents de (au moins 3 parmi les 5) : - maladie rénale - dysthyroïdie - maladie hépatique - hémopathie - dénutrition	1 pt	☐
2.	Recherche des antécédents dermatologiques spécifiquement	1 pt	☐
3.	Recherche une majoration vespérale du prurit	1 pt	☐
4.	Précise la localisation du prurit	1 pt	☐
5.	Recherche un médicament nouvellement introduit	1 pt	☐
6.	Recherche les antécédents psychiatriques spécifiquement	1 pt	☐
7.	Demande s'il y a eu des bulles sur le corps à un moment	1 pt	☐
8.	Recherche une AEG (1 pt si 2 parmi : perte de poids, fatigue inhabituelle, perte d'appétit)	1 pt	☐
9.	Recherche des sueurs nocturnes	1 pt	☐
10.	Recherche un prurit de l'entourage	1 pt	☐
11.	Recherche les traitements entrepris antérieurement	1 pt	☐
12.	Conclut à un possible **prurit médicamenteux** OU propose le diagnostique de **pemphigoïde bulleuse au stade pré-bulleux** *(bien que moins probable à ce stade)*	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Communications et attitudes

13.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

14.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

15.

Performance Insuffisante *Clear fail*	**Performance Limite** *Borderline*	**Performance Satisfaisante** *Clear pass*	**Performance Très Satisfaisante** *Very good pass*	**Performance Remarquable** *Excellent pass*
○	○	○	○	○
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	Conforme aux attentes	Au-delà des attentes	Très au-delà des attentes
Les attentes sont non observables ou non respectées Présente un niveau inacceptable de performance	Les omissions et les inexactitudes dans la réalisation des tâches Démontre du potentiel pour atteindre la compétence	Démontre les éléments essentiels de la performance Prêt pour avancer en toute sécurité	Quelques omissions/erreurs mineures et non essentielles Démontre la plupart des aspects de la compétence	Agit sans hésitation et sans erreur Démontre la maîtrise de tous les aspects de la compétence

TOTAL	**/ 15 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

<u>Éléments de rétroaction</u> :

Un prurit sine materia (ou plutôt "sans lésions spécifiques" qui est plus approprié, car il y a des lésions de grattage) appelle une démarche structurée.

Chez un sujet > 75 ans, il faut toujours penser à une pemphigoïde bulleuse au stade pré-bulleux, car c'est une maladie relativement fréquente (a fortiori chez les patients institutionnalisés ou avec des troubles cognitifs), assez grave. Et surtout que le diagnostic de certitude est aisé, avec un traitement spécifique qui en découle.

Il faut sinon dérouler les grands cadres de prurit sine materia : médicaments +++ (même si il est difficile d'être formel en général sur l'imputabilité), gale, hémopathie et cancer solide, …

Il faut toujours demander les antécédents dermatologiques.

Il faudra un bilan complet pour conclure à un prurit psychogène.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes médecin généraliste en ville.
Vous recevez Mme B., 81 ans, patiente que vous recevez pour la première fois.
Elle se plaint d'un prurit intense depuis 6 mois, généralisé.
Vous avez déjà examiné son corps entier, et vu seulement des lésions de grattage sur le tronc et les membres.

Vous allez l'interroger pour comprendre la cause de son prurit.

Plan de la station ECOS :

Patient simulé en face du candidat, autour du bureau.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Bonjour Docteur.
Je suis contente d'enfin vous rencontrer, cela fait 6 mois que je me gratte comme une damnée. J'espère ne pas être devenue folle !"

Identité du patient :

Mme L. 81 ans, IMC 26.

Mode de vie :

Ancienne documentaliste. Jamais fumé. Aucun trouble cognitif. Vit avec son mari. Très active. Pas d'animaux. Pas de tabac ni alcool.

Comportement global :

Angoissée mais adaptée.

Antécédents personnels :

- HTA

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

- Eczéma dans l'enfance
- Surpoids

Antécédents familiaux :

Néant

Médicaments :

IRBESARTAN
Doliprane à la demande

Symptômes positifs :

Prurit ayant débuté il y a 6 mois. Permanent.
Sites atteints : tronc, bras, jambes.
1er épisode.
Mari indemne.
Prurit la nuit, insomniant, sans aggravation particulière vespérale.
Retentissement important : sort moins, angoissée.

Aerius en auto-médication : pas d'effet hormis effet sédatif désagréable.
Dexeryl : sans effet.
A lavé plusieurs fois à 60° tous ses vêtements, et nettoyé de fond en comble sa maison : sans effet.

Début du SARTAN par son généraliste il y a 1 an.

Jamais de bulles.
Pas d'AEG, ni sueurs nocturnes.

Constantes :

Normales.

Questions de relance :

À 6 minutes, si l'étudiant ne l'a pas déjà fait, lui demander d'énoncer ses hypothèses.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Le patient standardisé est en face de l'étudiant, autour d'un bureau, avec 2 chaises.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)